FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA
SOMATOPSÍQUICA

Aula 3

Segurança

Teoria Polivagal e sua interface com a IPS

FASE 1 · HABITAR O CORPO

Guia de apoio à aula e à prática da semana

Segurança, regulação autonômica, corregulação
e vivência dos 7 passos no modo transformação.

Dra. Renata Guerra

Retome este material junto ao diário de prática e às fichas
disponíveis na área de membros.

A PERGUNTA QUE ABRE A AULA

Segurança e possibilidade de escolha

O paciente precisa compreender para se sentir seguro ou sentir alguma segurança para conseguir compreender?

Segurança organiza as condições para presença, vínculo e escolha.

Na aula, segurança é tratada como experiência corporal, relacional e contextual. Ela envolve perceber apoio no corpo, alguma previsibilidade na relação, orientação ao ambiente presente e liberdade para continuar, ajustar ou parar.

Segurança não significa ausência de ativação

Uma pessoa pode estar ativada e ainda manter contato consigo, reconhecer apoio e responder com alguma escolha. O objetivo clínico não é exigir calma. É preservar ou recuperar possibilidades de resposta.

Uma pausa para orientar-se

Mantenha os olhos abertos, se preferir. Observe o ambiente e pergunte: onde há apoio neste momento? Reconheça que você pode ajustar, continuar ou parar.

Quais sinais me ajudam a reconhecer alguma segurança no corpo, na relação e no ambiente?

REGULAÇÃO AUTONÔMICA

Ativação, contexto e flexibilidade

O sistema nervoso autônomo participa continuamente da regulação do ritmo cardíaco, da respiração e da digestão. Também integra respostas de mobilização, recuperação e adaptação ao contexto.

Ativação não é sinônimo de patologia

A ativação prepara o organismo para responder. Seu significado depende da situação, da intensidade, da duração e da possibilidade de recuperação. Evite o esquema simplista de simpático como ruim e parassimpático como bom.

Flexibilidade autonômica

Flexibilidade é conseguir mobilizar energia diante de uma demanda e, depois, reduzir a ativação sem perder completamente o contato. Trata-se de uma capacidade dependente do contexto, não de um estado permanente.

MOBILIZAR	RECUPERAR
Agir diante da demanda com energia e direção.	Reduzir a ativação preservando contato, orientação e escolha.

Na prática clínica

Antes de interpretar uma ativação como desregulação, investigue a função que ela cumpre, o contexto em que aparece e a capacidade da pessoa de transitar entre estados.

O alvo clínico é flexibilidade, não supressão fisiológica.

TEORIA POLIVAGAL

Um modelo clínico, não um diagnóstico

Segundo a Teoria Polivagal, três famílias ajudam a organizar didaticamente as respostas: conexão, mobilização e imobilização. Estados são respostas adaptativas e podem oscilar ou coexistir. Eles não constituem identidades fixas.

PADRÃO	FUNÇÃO E MANIFESTAÇÃO POSSÍVEL
Conexão	Favorecer engajamento social, contato, comunicação e disponibilidade.
Mobilização	Preparar o organismo para agir, com ativação, luta ou fuga.
Imobilização	Responder a determinadas ameaças, com congelamento ou desligamento defensivo.

Hierarquia default

A teoria propõe uma sequência hierárquica de respostas de defesa: engajamento social, mobilização e imobilização. Essa formulação dialoga com o princípio de Hughlings Jackson sobre o recurso a níveis mais arcaicos sob pressão. A sequência não deve ser tratada como inevitável nem usada para diagnosticar estados vagais.

Formulação clínica cuidadosa

Use a expressão “segundo a Teoria Polivagal”. Não atribua um comportamento a uma única via autonômica e não transforme o modelo em classificação diagnóstica.

PISTAS DE SEGURANÇA E AMEAÇA

Neurocepção e movimentos biológicos

Neurocepção é um constructo da Teoria Polivagal para descrever a detecção de segurança e ameaça sem depender de avaliação consciente deliberada. História, contexto e sinais corporais influenciam o que parece seguro ou ameaçador.

Relação com codificação preditiva

A aula aproxima neurocepção e codificação preditiva para pensar como modelos prévios e sinais atuais participam da resposta corporal. Essa aproximação não torna os dois modelos equivalentes.

Movimentos biológicos

Expressão facial, prosódia da voz e gesticulação podem funcionar como pistas relacionais. Na formulação da aula, o corpo responde a essas pistas antes de uma explicação verbal completa.

PISTA	PERGUNTA CLÍNICA
Expressão facial	O rosto comunica disponibilidade, tensão, distância ou acolhimento?
Prosódia	O ritmo e a entonação favorecem contato ou aumentam urgência?
Gesticulação e postura	Os movimentos ampliam previsibilidade e espaço ou parecem invasivos?

Do artigo ao consultório

Observe não apenas o conteúdo da pergunta clínica, mas também o ritmo, o tom de voz, a distância corporal e a possibilidade real de o paciente dizer não.

CORREGULAÇÃO

O corpo do profissional também participa da consulta

Segundo a Teoria Polivagal, a corregulação envolve estados fisiológicos recíprocos que se ajustam na relação. A proposta oferece uma base para pensar como voz, ritmo, presença e vínculo influenciam a experiência clínica.

Corregulação não significa controlar o outro

A influência acontece nos dois sentidos e depende do contexto. O profissional não é culpado pelo estado do paciente, mas participa da díade e pode observar como sua presença modifica o encontro.

Uma mudança de pergunta

Em vez de perguntar apenas “Por que ele não se regula?”, acrescente: “O que, nesta relação, muda a segurança?”

Sinais de segurança reduzida

- Respostas automáticas ou excessivamente intelectualizadas.
- Hipervigilância, urgência ou dificuldade de pausar.
- Retraimento, entorpecimento ou estranhamento corporal.
- Dificuldade de perceber escolha ou possibilidade de interromper.

Esses sinais não são diagnósticos. Eles convidam o profissional a reduzir a intensidade e investigar.

Corregulação cria um intervalo clínico no qual contato e escolha podem reaparecer.

LEITURA CRÍTICA

O que a ciência sustenta e o que permanece em debate

A aula separa fundamentos amplamente aceitos de premissas específicas da Teoria Polivagal que ainda recebem críticas.

EVIDÊNCIAS CONVERGENTES	PONTOS EM DEBATE
A regulação autonômica depende de contexto e da integração cérebro-corpo. Relações sociais podem modular respostas fisiológicas e emocionais.	A hierarquia filogenética proposta, a especificidade de algumas vias e a interpretação da arritmia sinusal respiratória. A Teoria Polivagal não representa consenso integral.

Uso responsável do modelo

- Utilize o modelo para formular perguntas clínicas, não para afirmar mecanismos não demonstrados.
- Evite rotular o paciente como “ventral”, “simpático” ou “dorsal”.
- Mantenha a avaliação psiquiátrica, diagnóstica e contextual completa.
- Reconheça que utilidade clínica e certeza neurofisiológica não são a mesma coisa.

“Segurança” não deve se tornar uma exigência de calma. Ativação, hesitação e desconforto também podem integrar uma experiência válida.

A VIVÊNCIA DA AULA 3

Os 7 passos da IPS no modo transformação

Escolha uma situação cotidiana de insegurança com intensidade leve ou moderada. Não acesse a experiência mais difícil, trauma, crise recente ou situação altamente desorganizadora. Durante toda a prática, você pode abrir os olhos, reduzir o ritmo, mudar o foco ou interromper.

1. Presença e enraizamento

Reconheça os pés e os pontos de apoio. Oriente-se ao ambiente atual e perceba a respiração sem modificá-la. Pergunte: o que oferece algum apoio agora?

2. Mapeamento Somatopsíquico

Traga a situação apenas o suficiente para perceber a resposta. Observe postura, respiração e direção do corpo. Depois, explore localização, qualidade, ritmo e limites da sensação. Há impulso de aproximar, afastar, proteger, esconder ou agir?

3. Agência Somatopsíquica

Pergunte que pequeno movimento poderia aumentar apoio, proteção ou possibilidade de escolha. O movimento pode ser um gesto, uma postura, uma palavra, uma mudança na direção do olhar ou um ajuste espontâneo da respiração.

4. Remapeamento Somatopsíquico

Observe o que mudou e o que permaneceu. Como está agora a sensação inicial? Surgiu mais apoio, firmeza, espaço ou mobilidade? De 0 a 10, quanto a situação mobiliza você neste momento? Qualquer resultado é informação.

A VIVÊNCIA DA AULA 3

Insight, silêncio e fechamento

5. Insight Somatopsíquico

Permita que uma palavra, frase ou imagem surja da experiência. Não force uma resposta. O insight ajuda a integrar o percurso vivido.

Pergunta central

Que palavra, frase ou imagem emerge agora?

6. Atenção Plena e silêncio meditativo

Permaneça por um momento com a experiência atual. Perceba corpo, respiração, sons e ambiente. O silêncio oferece tempo para a experiência assentar.

Pergunta central

O que percebo quando permaneço sem acrescentar uma nova ação?

7. Fechamento e integração

Reconheça o que leva da prática e como isso se relaciona com a situação escolhida. Compartilhe apenas o que desejar.

Pergunta central

O que levo desta vivência e qual pequeno passo se tornou possível?

Quando diminuir o ritmo

- Oriente novamente ao ambiente e mantenha os olhos abertos.
- Retome pés, apoios e movimentos pequenos.
- Confirme consentimento e possibilidade de interromper.
- Evite exploração profunda quando o contato diminui.

DO ARTIGO AO CONSULTÓRIO

Segurança como condição de trabalho clínico

Antes de aprofundar uma experiência, avalie se o paciente mantém orientação, contato e alguma possibilidade de escolha. Segurança suficiente favorece presença. Presença amplia possibilidade. Movimento pode sustentar agência.

Perguntas clínicas possíveis

- O que seu corpo faz quando você se sente inseguro?
- O que oferece algum apoio neste momento?
- Você percebe impulso de aproximar, afastar, proteger-se ou agir?
- Que pequeno movimento aumentaria sua possibilidade de escolha?
- Você prefere continuar, adaptar ou parar?

Prática da semana

Quando me sinto inseguro, o que meu corpo faz?

Observe brevemente o corpo, a relação e a possibilidade de escolha. Reconheça um apoio e experimente um pequeno movimento possível. A prática é observacional e não exige reduzir a ativação.

Registro

No corpo, percebi:

Na relação e na escolha, percebi:

INTEGRAÇÃO E CONTINUIDADE

O que levo deste encontro?

Como reconheço segurança suficiente no meu corpo?

O que muda na relação quando minha prosódia e meu ritmo mudam?

Que movimento ampliou apoio ou possibilidade de escolha?

Biblioteca Somatopsíquica

Porges SW. *Polyvagal theory: a journey from physiological observation to neural innervation and clinical insight*. Front Behav Neurosci. 2025;19:1659083. doi:10.3389/fnbeh.2025.1659083.

Manzotti A, Panisi C, Pivotto M, et al. *An in-depth analysis of the polyvagal theory in light of current findings in neuroscience and clinical research*. Dev Psychobiol. 2024;66(2):e22450. doi:10.1002/dev.22450.

Grossman P. *Fundamental challenges and likely refutations of the five basic premises of the polyvagal theory*. Biol Psychol. 2023;180:108589. doi:10.1016/j.biopsycho.2023.108589.

Guerra RA et al. *Theory and conception of Somatopsyche Psychiatric Intervention: a transdiagnostic body-mind intervention for psychiatric practice*. Front Psychiatry. 2025;16:1644739. doi:10.3389/fpsyt.2025.1644739.

Segurança não é ter certeza de que nada difícil acontecerá. É perceber que posso me apoiar, responder e permanecer comigo diante do que acontece.

Base deste guia: apresentação revisada da Aula 3, de Dra. Renata Fáro Guerra. Síntese didática para os participantes da formação. Conceitos, limites e orientações seguem os materiais da autora.